Der Algorithmus greift nur, wenn

1. ein Infekt UND
2. Allgemeinsymptome vorliegen (s.u.) UND
3. der klinische Zustand des Patienten die Arbeitsdiagnose Septischer Schock rechtfertigt.

Sepsis:

Infekt, z.B.
- **Lunge (Bronchitis / Pneumonie)**
- **Harnweg (vor allem bei Blasenkatheter)**
- **Abdomen (z.B. bei Peritonismus)**
- **Haut (Erysipel, Phlegmone, Wunden)**
- **etc.**

UND

Allgemeinsymptome, z.B.
- **Fieber**
- **Hypothermie**
- **Tachypnoe**
- **Tachykardie (> 100/min)**
- **Hypotonie (< 100 mmHg syst)**

In den Schulungsalgorithmen des Landes Hessen wird der modifizierte New Early Warning Score 2 (NEWS2) für die Einschätzung der Gefährdung des Patienten vorgegeben:

	Je nach Ausmaß der Abweichung vom Normwert zu vergebene Punkte						
Parameter	3	2	1	0	1	2	3
Atemfrequenz [pro Minute]	≤ 8		9–11	12–20		21–24	≥ 25
O_2-Sättigung [%]	≤ 91	92–93	94–95	≥ 96			
O_2-Gabe		ja		nein			
Temperatur [°C]	≤ 35,0		35,1–36,0	36,1–38,0	38,1–39,0	≥ 39,1	
Systolischer Blutdruck [mmHg]	≤ 90	91–100	101–110	111–219			≥ 220
Herzfrequenz [pro Minute]	≤ 40		41–50	51–90	91–110	111–130	≥ 131
Vigilanz [ACVPU]				wach, orientiert			desorientiert, keine Reaktionen, keine Reaktion auf Ansprache oder Schmerzreiz

Triggergrenzwerte	0–4 Punkte	1 x 3 Punkte oder 5–6 Punkte	≥ 7 Punkte
Risiko	niedrig	mittel	hoch
Klinische Reaktion	Patient beobachten	**dringende** Beurteilung des Patienten durch den ärztlichen Dienst innerhalb von 20–30 Minuten	**sofortige** Beurteilung des Patienten durch einen Facharzt mit Notfallkompetenz
Monitoringfrequenz	0 Punkte: alle 12 Stunden 1–4 Punkte: mindestens alle 4–6 Stunden	mindestens stündlich	kontinuierlich

Quelle: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2